

إسم المريض ربيعاً : حنان حسنى على حسن
المحافظة : الجيزة الحي / المدينة : الهرم
رقم البطاقة : 27606262300789 رقم التليفون : 01144791362
العمر(تاريخ الميلاد) : 26-06-1976 المهنة : ربه منزل
العنوان : هرم
تاريخ تسجيل الإستمارة : 20-09-2026

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-
الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة
نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (-----) التوقيع: (-----)

المقر بما فيه التوقيع: (-----)

التعليق على التشخيص : -----

GR I-E

رستم جويستاقوف
روستام جويدى
لدى حسين رمضان
موسين روستايف

صحة الايامات المرفقة
للجنة مدير

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

----- / د ----- / د ----- / د. | ----- / د. |

ملاحظات : ---

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: حنان حسنى على حسن National ID: 27606262300789	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



حسان
حسنی علی حسن
مفتی البیان رشاح ابو عوض شوریجی
الهرم - الجيزة

٢٧٦٠٠٦٢٦٢٣٠٠٧٨٩

LB8325330



٢٠٣٥/٠٤ ٢٧٦٠٠٦٢٦٢٣٠٠٧٨٩
ریہ منزل
مفتی مسلمہ
رضا عاشور محمود علی
البحاثة ساریة حسی ٢٠٣٢/٠٤/٠٢



DMS

اربع سے وکھیل

ایک

تدعیس



MDT form

A-Patient ID:

1- Name : حنان حسني علي حسن

Sex:

3- Medical number:

Female

83218449

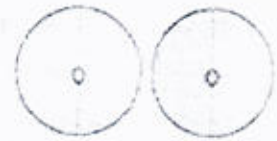
Old Med :

Date:

21/09/2024

2-ID numbers:

Patient Age : 48 Y



Family history

Family history

Phone

Phone

01144791362

BMI

BP

REASON OF MDT

Reason of MDT
Investigation of

marital status

Marital status

NRS Score

NRS Score

GROUP

GROUP

Date of MDT

Date of MDT

10/12/2024

Co morbidity

Co morbidity

on eltrexin 100

Menopausal
status

Menopausal Status
ON THE MENOPAUSE

Initial STAGE

Initial STAGE

Clinical data

Breast Imaging :

rt UIQ parenchyma distortion with grouped microcalcification
BIRADS 4

Mets Workup :

few osseous lesion

no sizable pulmonary or hepatic deposits

BX IOC	ER 8/8	PR 8/8	Her 2 Neu 0	SISH	Ki67 20-30
ER Comment	ER Comment	PR Comment	Her 2 Neu Comment	SISH Comment	Ki67 Comment

T 2	N 0	M
--------	--------	---

Sonomanimography

PATIENT HISTORY

pt received only 1 month zoladex and AI

ALL met work up revealed to be free

MRM: T 2 LN 2/7

MDT OUTCOME & PLAN

4 cycles TC (docetaxel-cyclophosphamide)

PORT

femara+LHRH for 5 years

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	MEDICAL ONCOLOGY Signature	RADIOLOGY	RADIOLOGY Signature
SURGERY	SURGERY Signature	PATHOLOGY	PATHOLOGY Signature
Psychiatric	Psychiatric Signature	Nutrition	Nutrition Signature

Patient Name : الأستاذة / حنان حسنى على حسن	Request No. : 13005382
Patient No. : 27606262300789	Request Date : 09/11/2024
Path No. : 4327/24	Verification Date : 27/11/2024
Sex : Female	Financial Category : اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age : 48 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

- Lateral and deep margins are free.
- Histologic response to therapy: Pathologic partial response.
- Additional pathologic findings: Microcalcifications and fibroadenosis.
- 3) Sentinel lymph node involvement: Positive (2/7) with no capsular invasion.
- 4) Completion mastectomy:
 - Ductal carcinoma insitu, intermediate grade.
 - Fibrocystic changes.
 - Skin involvement: Free nipple and areola.
 - Resection Margins: Free deep margin.
- 5) Accessory breast:
 - Unremarkable, free of malignancy.

Diagnosis:

- Right breast cancer, completion mastectomy and sentinel lymph node biopsy specimens:
- Invasive duct carcinoma, grade II with extensive DCIS.
 - Free nipple and areola.
 - Free deep margin.
 - Lymph nodes: Positive (2/7) with no capsular invasion.
 - Pathologic partial response.
 - Stage : ypT2, N1a.
 - RC8:3 842, class III.
 - Accessory breast was unremarkable, free of malignancy.

Prof. Gamal Abdelatty
Dr. Rofa Abdallah

Verified by :

Printing Date : 28/11/2024 13:29:19

Page 3 of 4

Printing By : Mrs. Mayada Hegazy

CAP

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name : الأستاذة / حنان حسني علي حسن	Request No. : 13005382
Patient No. : 27606262300789	Request Date : 09/11/2024
Path No. : 4327/24	Verification Date : 27/11/2024
Sex : Female	Financial Category : أورام نادر السلام - نفقة الدولة
Age : 48 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

from least deep margin.

5) accessory breast excision: A fibrofatty tissue piece measured 6.5x4.5x2.5 cm with covered skin ellipse measured 4.4x3 cm. Cut section was unremarkable pathology.

• Frozen section:

- Both wide local excision margins are involved by DCIS with possibility of invasion.
- Superficial margin of second specimen is involved by invasive component.
- positive for microcalcifications.
- Positive nodes (1/3).

Microscopic examination:

1) First wide local excision specimen:

breast:

- Histological type: Ductal carcinoma insitu, intermediate grade.
- No evidence of invasion.
- Additional pathologic findings: Extensive fibroadenosis, sclerosing adenosis with usual ductal hyperplasia and microcalcifications.

• Resection Margins:

- Superior, lateral margins are positive for DCIS.
- Skin and rest of margins skin are free showing usual ductal hyperplasia.

2) Second wide local excision:

- Histological type: Invasive duct carcinoma.
- Grade (differentiation + nuclear pleomorphism + mitosis): G II (3+2+1).
- Actual tumor cellularity: 50%.
- Angioinvasion: Occasional.
- Ductal carcinoma in situ: Focal (20%).
- Resection Margins:
- Superior and superficial are positive invasive component.
- Inferior and medial margins are positive DCIS.

Verified by :